



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN INSTALASI
KAMAR OPERASI
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi

Rumah Sakit Prima Husada

Tahun 2025

Disusun oleh :

Kepala Instalasi Kamar Operasi



(dr. Robby, Sp. An)

Disetujui oleh :

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHT., CI., CHAE., CHQP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., Cl., CHAE., CHQP
2. dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS

PENYUSUN

1. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
2. dr. Harli Noviar Kagendra Sp. An
3. dr. Ghuraba Adisurya, Sp. An
4. dr. Robby Sp. An TI
5. dr. Denny Prasetyo Sp. An, TI
6. dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG
7. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG.
8. dr. Agung Wijaya Kusuma Sp. OG
9. dr. Zaki Yamani, Sp.B
10. dr. Djanuar Fitriadi Sp. B
11. dr. Angga Prawira Purwanto Sp. B
12. dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS
13. dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K)
14. dr. Nurhadi Sutanto, Sp. M
15. dr. Indra Bayu, Sp.M
16. dr. Latifa Sp. M
17. dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp. U
18. dr. Arianto Prabowo, Sp. OT
19. dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT
20. dr. Fiski Purantoro, Sp. OT
21. dr. Julian Hertawan, Sp.T.H.T.K.L
22. dr. Fuad, Sp.T.H.T.K.L
23. Dr. riski bagus Suhendra, Sp. DVE
24. Rizky Dwi Ramadhani, Amd. Kep
25. Riski Rahmawan, S. Kep., Ns
26. Muhammad Wafi Taufik, S. Kep., Ns
27. Edo Fardiantoko, Amd. Kep
28. Syafendra Priyo Utomo, Amd. Kep
29. Kikis Setyawati, Amd. Kep.
30. Farid Wahyudi Antok, Amd. Kep
31. Agung Pratama, Amd. Kep
32. Eko Puji Pangestu, Amd. Kep
33. Silfi Fauziyah, Amd. Kep
34. Ns. Danang Suronoputro, S. Kep
35. Nikholas Sendy Pradana, A.Md.Kep
36. Moch. Agung Setiawan, Amd. Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan buku pedoman pelayanan Instalasi Kamar Operasi Rumah Sakit Prima Husada. Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025 meliputi kamar operasi, kemampuan pelayanan, standart ketenagaan.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan panduan ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku panduan ini. Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025 ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 15 Januari 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



(dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS)

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/II/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada maka diperlukan adanya kebijakan pelayanan Instalasi Kamar Operasi yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Kepdirjen Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
10. Pedoman Instalasi Pusat Steril di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI tahun 2009;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (015 Januari 2026 hingga tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Standar pelayanan kamar operasi adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pemberi asuhan kepada pasien operasi dalam menyelenggarakan pelayanan di kamar operasi.
- (3) Pelayanan kamar operasi adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan pasien operasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- (4) Pelayanan bedah adalah pelayanan medis kepada pasien dalam tindakan operasi.
- (5) Rekam medis adalah bukti tertulis (kertas / eletronik) yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti temuan hasil pengkajian, rencana asuhan, rincian pelaksanaan asuhan dan pengobatan, catatan perkembangan pasien terintegrasi, serta ringkasan kepulangan pasien yang dibuat oleh profesional pemberi asuhan (PPA).
- (6) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya.
- (7) Implant adalah salah satu alat kesehatan yang tidak mengandung obat, digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- (8) *Sign in* adalah langkah pertama yang dilakukan segera setelah pasien tiba di ruang serah terima sebelum dilakukan induksi anestesi.
- (9) *Time out* adalah langkah kedua yang dilakukan pada saat pasien sudah berada di ruang operasi, sesudah induksi anestesi dilakukan dan sebelum ahli bedah melakukan sayatan kulit.
- (10) *Sign Out* adalah tahap akhir yang dilakukan saat sebelum insisi luka ditutup dan sebelum pasien dikeluarkan dari kamar operasi. Proses ini dilakukan untuk melakukan konfirmasi penggunaan kasa, benda tajam, instrumen atau lainnya serta memberikan perhatian khusus terhadap kondisi khusus pada pasien post operasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Kamar Operasi di Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kamar operasi;
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kamar operasi; dan

- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari kejadian salah prosedur, salah lokasi dan salah pasien operasi dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

BAB III PELAYANAN KAMAR OPERASI

Bagian Kesatu Penjadwalan Pelayanan Kamar Operasi

Pasal 3

Perawat Intalasi Rawat Inap / Instalasi Gawat Darurat / Instalasi Rawt Jalan konfirmasi penjadwalan pelayanan operasi ke IKO H-1 pasien di lakukan Tindakan

Pasal 4

Pelayanan kamar operasi elektif dilakukan setiap hari senin-sabtu mulai pukul 06:00-21:00 dan *emergency* selama 24 jam.

Pasal 5

Semua ruang tindakan pembedahan yang berada dalam instalasi lain meliputi aturan, kebijakan, pengelolaan dan SPO yang digunakan mengacu dengan yang ada di Instalasi Kamar Operasi.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Bedah

Pasal 6

Jenis pelayanan bedah yang dapat dilaksanakan sesuai regulasi dalam Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi

Bagian Ketiga Penundaan Pelayanan Kamar Operasi

Pasal 7

Bila ada penundaan atau perubahan jadwal operasi dari salah satu dokter segera diinformasikan kepada pasien, keluarga pasien, dokter dan tim lainnya.

Pasal 8

Bila terjadi perubahan jam pelayanan pasien karena waktu operasi sebelumnya memanjang atau hal lain, maka yang menjelaskan kepada pasien / keluarga adalah manager pelayanan pasien.

BAB IV KOMUNIKASI DAN EDUKASI PELAYANAN KAMAR OPERASI

Pasal 9

Pasien, keluarga atau pembuat keputusan diberikan edukasi atas risiko dari prosedur yang direncanakan, manfaat prosedur yang direncanakan, komplikasi yang potensial terjadi, dan alternatif tindakan bedah dan non bedah yang tersedia untuk mengobati pasien, bila darah atau produk darah mungkin dibutuhkan, informasi tentang risiko dan alternatif di diskusikan.

Pasal 10

Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan operasi diberikan informasi / penyuluhan mengenai prosedur operasi yang akan dijalani, kunjungan pra anastesi di ruang perawatan paling lambat 1 hari (1x24 jam) sebelum dilakukan tindakan pembedahan untuk kasus elektif dan di ruang pre operasi sebelum induksi untuk pasien cito.

BAB V PENGKAJIAN BEDAH

Pasal 11

Asuhan pasien bedah direncanakan berdasarkan hasil pengkajian.

Pasal 12

Pengkajian didokumentasikan dalam rekam medis dan ditandatangani oleh dokter.

BAB VI PROSES PELAYANAN KAMAR OPERASI

Bagian Kesatu Persiapan Pasien Operasi

Pasal 13

Pengiriman pasien ke kamar operasi untuk operasi elektif adalah 1 jam sebelum jam operasi tanpa menggunakan atau membawa alas kaki dan perhiasan serta make up di bagian wajah serta kuku tidak panjang dan di warnai.

Pasal 14

Bila diperlukan pencukuran area operasi, pencukuran dilakukan di ruang rawat inap atau ruang preoperasi.

Pasal 15

Setiap pasien datang dikamar operasi dilakukan identifikasi pasien.

Pasal 16

Persiapan pembiusan harus dilakukan 1 jam sebelum *incisi*.

Pasal 17

Sebelum operasi dimulai lampu indikator kegiatan operasi dinyalakan.

Pasal 18

Setiap dilakukannya pembedahan di kamar operasi harus melaksanakan *surgical safety checklist* pada pasien yang meliputi *Sign In, Time Out* dan *Sign Out*.

Bagian Kedua Laporan Operasi

Pasal 19

Dokter Operator membuat Laporan operasi.

Pasal 20

Laporan operasi diisi sebelum pasien dipindah ke Instalasi rawat inap atau pasien pulang.

Bagian Ketiga Rencana Asuhan Pasca Operasi

Pasal 21

Instruksi pasca operasi dan pemantauan selanjutnya harus dicatat dalam rekam medis.

Pasal 22

Rencana asuhan pasca operasi dibuat dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat dan professional pemberi asuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasien pasca operasi.

Bagian Keempat Penggunaan Implant

Pasal 23

- (1) Tindakan bedah yang menggunakan implant prostetik antara lain panggul dan lutut dikelola oleh rumah sakit.
- (2) Penempelan Implant di tempel di rekam medis.

Bagian Kelima Komunikasi dan Edukasi dalam Proses Operasi

Pasal 24

Bila ada tindakan perluasan tindakan operasi, operator harus memberikan informasi kepada penanggung jawab pasien sebelum perluasan operasi dilakukan dan penanggung jawab pasien harus menandatangani *informed consent*.

Bagian Keenam Proses Pemulihan dan Pemindahan Pasca Operasi

Pasal 25

Selama periode pemulihan pasca anestesi, pasien dimonitor menggunakan monitor pasien dan dievaluasi setiap 15 menit pada 1 jam pertama, selanjutnya tiap 30 menit sampai pasien sesuai dengan kriteria pemulihan yaitu *aldert*, *steward* dan *bromage score* oleh perawat di ruang *Recovery Room* (RR).

Pasal 26

Pasien dipindahkan dari ruang pemulihan sesuai kriteria *aldert*, *steward* dan *bromage score* ke ruang rawat inap atau ICU, dan dipulangkan oleh IRNA.

BAB VII PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 28

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 15 Januari 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGESAHAN	
PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pelayanan	1
1.3 Batasan Operasional	2
BAB II STANDAR KETENAGAAN	
2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia	3
2.2 Distribusi Ketenagaan	3
2.3 Pengaturan Jaga/Dinas	3
BAB III STANDAR FASILITAS	
3.1 Denah Ruang	4
3.2 Standar Fasilitas	5
BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN	
4.1 Kemampuan Pelayanan Bedah Umum	12
4.2 Kemampuan Pelayanan Obstetri dan Gynecology	12
4.3 Kemampuan Pelayanan Orthopedi	13
4.4 Kemampuan Pelayanan Urologi	13
4.5 Kemampuan Pelayanan Bedah Plastik	14
4.6 Kemampuan Pelayanan Bedah Saraf	14
4.7 Kemampuan Pelayanan Mata	14
BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN	
5.1 Alur Kamar Operasi	15
5.2 Manajemen Pre Operatif	16
5.3 Manajemen Intraoperatif	19
5.4 Manajemen Postoperatif	21
BAB VI LOGISTIK	24
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	
7.1 Pengertian Keselamatan Pasien	25
7.2 Tujuan Keselamatan Pasien	25
7.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien	25
7.4 Alur Pelaporan Insiden ke Tim Keselamatan Pasien (KP) di RS	27
7.5 Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien	28
7.6 Analisis Matriks Grading Resiko	29
BAB VIII KESELAMATAN KERJA	
8.1 Pengertian Keselamatan Kerja	32
8.2 Tujuan Keselamatan Kerja	32
8.3 Tata Laksana Keselamatan Karyawan	32
BAB IX PENINGKATAN MUTU	
9.1 Prinsip	34
9.2 Definisi Indikator	34
9.3 Kriteria	34
9.4 Standar	34
BAB X PENUTUP	35

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 037.1/RSPHS/E-
PER/DIR/I/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
KAMAR OPERASI

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kamar operasi adalah suatu instalasi khusus rumah sakit yang merupakan suatu tempat untuk melakukan tindakan pembedahan baik operasi elektif maupun emergensi yang membutuhkan keadaan dan peralatan yang steril dan juga termasuk fasilitas yang mempunyai banyak persyaratan. Tindakan pembedahan atau tindakan operasi merupakan tindakan yang kompleks, penyulit dari tindakan pembedahan dapat disebabkan oleh aspek SDM, fasilitas / alat dan juga lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan kedokteran telah menjadikan pembedahan yang dahulu sebagai usaha terakhir, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang dapat diterima secara umum. Pelayanan keperawatan di kamar operasi juga ikut berkembang dari hari kehari, dimana kegiatan keperawatan mulai dari identifikasi kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial pasien dan implementasi dari asuhan keperawatan yang bersifat individualistik, mengkoordinasikan semua kegiatan keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan, ilmu biomedis, ilmu perilaku dan ilmu alam dasar dalam rangka memulihkan dan mempertahankan kesehatan, kesejahteraan pasien sebelum, selama, dan sesudah tindakan pembedahan.

Di dalam instalasi kamar operasi terdapat unit steril, dimana unit steril merupakan salah satu mata rantai yang penting untuk mengendalikan infeksi dan berperan dalam upaya menekan kejadian infeksi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, unit steril sangat bergantung pada unit penunjang lainnya yang ada di rumah sakit. apabila terjadi hambatan pada salah satu unit tersebut maka pada akhirnya akan mengganggu proses dan hasil sterilisasi. Unit steril bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap semua kebutuhan kondisi steril atau bebas dari semua mikroorganisme termasuk endospora secara tepat dan cepat.

1.2 RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pedoman ini diterapkan kepada semua perawat, penata / dokter anestesi, dan dokter yang terlibat dalam proses pembedahan pasien dalam suatu prosedur bedah.

1.3 BATASAN OPERASIONAL

Pembedahan atau operasi merupakan cara dokter untuk mengobati kondisi yang sulit atau tidak mungkin disembuhkan hanya dengan obat-obatan sederhana. Oleh karenanya tindakan pembedahan termasuk sebagai salah satu tindakan kedokteran yang beresiko tinggi, karena tujuan akhirnya adalah pasien dapat

bebas dari rasa nyeri dan stress psikis serta pasien dapat pulih kembali pasca operasi sesuai dengan derajat berat ringannya jenis pembedahan yang dialami pasien serta mempertahankan status fisiologis pasien secara optimal terhadap stressor tindakan pembedahan. Adanya resiko yang tinggi tersebut menuntut adanya manajemen terhadap resiko tersebut agar pelayanan pembedahan dapat berjalan aman, lancar dan sukses dengan memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan pasien.

BAB II
STANDART KETENAGAAN

2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menyelenggarakan pelayanan anastesi dan bedah di RS Prima Husada, petugas harus memiliki persyaratan:

- 1. Minimal lulusan D III Keperawatan
- 2. Memiliki STR yang aktif
- 3. Memiliki sertifikat kompetensi yang diperlukan seperti Anastesi / Instrument
- 4. Mempunyai surat izin kerja yang aktif

2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN

Tenaga kamar operasi yang terlibat di Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari:

Tabel 2.1 Distribusi Ketenagaan Kamar Operasi

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
1.	Kepala Instalasi Kamar Operasi	Menyesuaikan	1
2.	Kepala Ruang Instalasi Kamar Operasi	1 shift	1
3.	Penata Anastesi	2 shift	3
4.	Perawat Instrument	3 shift	6
5.	Perawat Sirkuler	3 shift	3
6	Perawat Recover Room	1 shif	1

2.3 PENGATURAN JAGA/Dinas

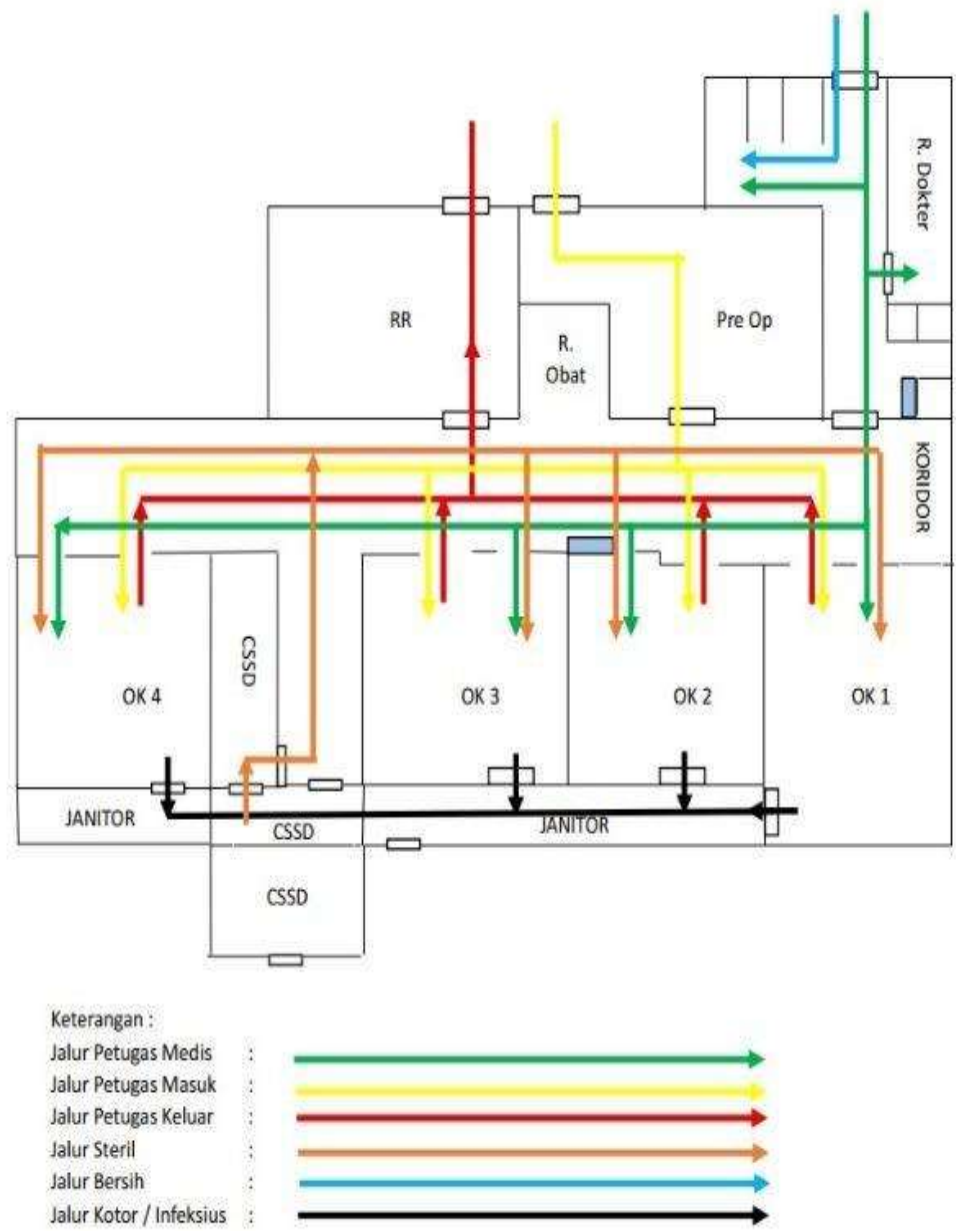
Pengaturan Jaga di Instalasi Kamar Operasi Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pengaturan Jaga Kamar Operasi

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1.	Kepala Instalasi Kamar Operasi	Menyesuaikan	On call	1
2.	Kepala Ruang IKO	2 shift	06.30-14.00 08.0016.00	1
3.	Penata Anastesi	3 shift	06.30-14.00 14.00-21.00 21.00-07.00	3
4.	Perawat Instrument	3 shift	06.30-14.00 14.00-21.00 21.00-07.00	6
5.	Perawat Sirkuler	3 shift	06.30-14.00 14.00-21.00 21.00-07.00	3
6.	Perawat Recover Room	1 shift	10.00-18.00	1

BAB III
STANDART FASILITAS

1.1 DENAH RUANG



1.2 STANDART FASILITAS

A. Bangunan

1. Jenis ruangan operasi di rumah sakit terdiri dari ruangan bedah minor, ruangan bedah umum, dan ruangan bedah kandungan.
2. Desain tata ruang operasi harus memenuhi ketentuan zona berdasarkan tingkat sterilitas ruangan yang terdiri dari:
 - a. zona steril rendah;
 - b. zona steril sedang;
 - c. zona steril tinggi;
 - d. zona steril sangat tinggi; dan
3. Dalam hal ruang operasi menyatu dengan ruang lain dalam satu bangunan, ruang operasi harus merupakan satu kompartemen.
4. Sistem ventilasi di ruang operasi harus tersaring dan terkontrol serta terpisah dari sistem ventilasi lain di rumah sakit untuk kepentingan pengendalian dan pencegahan infeksi.
5. Selain memenuhi ketentuan, sistem ventilasi harus terpisah antara satu ruangan operasi dengan ruangan operasi lainnya.

B. Sarana

1. Ruang administrasi
 - a. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3~5 m²/petugas.
 - b. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
 - c. Intensitas cahaya minimal 100 lux.
2. Ruang transfer / ganti brankar
 - a. Bahan daun pintu masuk tahan terhadap benturan brankar, arah bukaan pintu ke dalam.
 - b. Luasan minimal 12 m².
 - c. Ruangan ini merupakan ruangan dengan *prefilter* (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999).
3. Ruang Tunggu
 - a. Luas ruangan tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1~1,5 m²/orang.
 - b. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
 - c. Ruangan tunggu dilengkapi dengan Fasilitas Desinfeksi tangan.
4. Ruang Persiapan Pasien
 - a. Bahan daun pintu masuk tahan terhadap benturan brankar, arah bukaan pintu ke dalam.
 - b. Luas ruangan sesuai kebutuhan kapasitas pelayanan, dengan perhitungan luas per-tt minimal 8m².
 - c. Ruangan dilengkapi dengan toilet pasien yang memenuhi persyaratan.
 - d. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
 - e. Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengaman arus.
 - f. Harus disediakan outlet oksigen.
 - g. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
 - h. Intensitas cahaya 200 lux.
 - i. Ruangan ini merupakan ruangan dengan *prefilter* (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999).
5. Ruang Monitoring Perawat

- a. Luas ruangan pos perawat minimal 8 m² atau 3-5 m² per perawat, disesuaikan dengan kebutuhan. Satu pos perawat melayani maksimal 25 tempat tidur.
 - b. Luas ruangan harus dapat mengakomodir lemari arsip dan lemari obat.
 - c. Disediakan instalasi untuk alat komunikasi.
 - d. Disediakan fasilitas desinfeksi tangan (*handscrub*).
 - e. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux untuk penerangan.
6. Ruang Antara (*Airlock*)
- a. Ruang ini dapat dimanfaatkan sebagai ruangan induksi.
 - b. Luas ruangan ini minimal 9m².
 - c. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
 - d. Pintu masuk dari koridor ke ruangan ini dan pintu masuk ke ruangan operasi persyaratannya sbb:
 - 1) Pintu ayun (*swing*) membuka ke dalam ruangan atau disarankan pintu geser dengan rel diatas yang dipasang pada bagian luar ruangan, dapat dibuka tutup secara otomatis dan dapat dioperasikan secara manual apabila terjadi kerusakan.
 - 2) Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu (*door closer*), menggunakan door seal and interlock system.
 - 3) Lebar pintu min. 120cm, dari bahan non porosif, disarankan bahan panel (*insulated panel system*) dan dilapisi bahan anti bakteri/ jamur dengan warna terang, serta tahan terhadap bahan kimia.
 - 4) Pintu dilengkapi dengan kaca jendela pengintai (*observation glass*).
 - e. Ruang ini disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus.
 - f. Disediakan aliran gas medik oksigen, udara tekan dan vakum medik.
 - g. Jenis *airlock* yang digunakan adalah *cascading* (mencegah ruangan bersih terkontaminasi dari udara luar yang kotor dan dari ruangan sekelilingnya melalui celah), dengan tekanan udara lebih positif dari tekanan udara di koridor).
 - h. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
 - i. Intensitas cahaya minimal 200 lux.
 - j. Ruang ini merupakan ruangan semi steril dengan medium filter (tingkat resiko tinggi), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 352.000 partikel (ISO 7 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).
7. Ruang Cuci Tangan
- a. Setiap 1 ruangan ini minimal melayani 2 ruang operasi.
 - b. Luas ruangan minimal 6 m².
 - c. Disediakan fasilitas scrubbing lengkap dengan fasilitas desinfeksi tangan.
 - d. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
 - e. Pada sisi dinding yang berbatasan dengan ruangan operasi, dilengkapi dengan kaca jendela pengintai (*observation glass*).
 - f. Ruang ini merupakan ruangan dengan prefilter (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).
8. Ruang Persiapan Alat atau Bahan
- a. Setiap 1 ruangan ini dapat melayani 2 ruang operasi.
 - b. Luas ruangan minimal 9m².

- c. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
 - d. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
 - e. Tekanan udara dalam ruangan ini lebih besar / positif dibandingkan dengan di koridor.
 - f. Ruangan ini merupakan ruangan semi steril dengan medium filter (tingkat resiko tinggi), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 μm per m^3 yaitu 352.000 partikel (ISO 7 - ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999).
9. Ruang Operasi
- a. Luas ruangan adalah sbb:
 - 1) Ruangan operasi minor, $\pm 36 \text{ m}^2$, dengan ukuran ruangan panjang x lebar x tinggi adalah 6m x 6m x 3m.
 - 2) Ruangan operasi umum, minimal 42 m^2 , dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 7m x 6m x 3m.
 - 3) Ruangan operasi mayor / khusus, minimal 50 m^2 , dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 7.2m x 7m x 3m.
 - b. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, yaitu :
 - 1) Komponen penutup lantai harus non porosif, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, bersifat anti statik, anti gesek dan anti bakteri.
 - 2) Pertemuan lantai dengan dinding konus / melengkung (*hospital plint*).
 - 3) Tingkat Ketahanan Api (TKA) material lantai min. 2 jam.
 - 4) Komponen dinding *non porosif*, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, anti jamur dan bakteri.
 - 5) Pertemuan antara dinding dengan dinding konus / melengkung.
 - 6) Tingkat Ketahanan Api (TKA) material dinding min. 2 jam.
 - 7) Semua peralatan yang dipasang di dinding harus dibenamkan (*recessed*), misal film viewer, jam dinding, dan lain-lain.
 - 8) Komponen langit-langit non porosif, mudah dibersihkan, anti jamur dan bakteri, tidak memiliki unsur yang membahayakan pasien.
 - 9) Tingkat Ketahanan Api (TKA) material langit-langit minimal 2 jam.
 - 10) Semua peralatan lampu dipasang dibenamkan di plafon (*recessed*).
 - c. Semua pintu masuk ke ruangan operasi persyaratannya sbb:
 - 1) Pintu ayun (*swing*) membuka kedalam ruangan atau disarankan pintu geser dengan rel diatas yang dipasang pada bagian luar ruangan, dapat dibuka tutup secara otomatis dan dapat dioperasikan secara manual apabila terjadi kerusakan.
 - 2) Pintu-pintu dilengkapi dengan "alat penutup pintu (*door closer*), menggunakan *door seal and interlock system*.
 - 3) Lebar pintu yang dilalui pasien min. 120cm, dan yang dilalui petugas min. 85 cm, terbuat dari bahan *non porosif*, disarankan bahan panil (*insulated panel system*) dan dicat jenis cat anti bakteri / jamur dengan warna terang.
 - 4) Pintu-pintu dilengkapi dengan kaca jendela pengintai (*observation glass*).
 - d. Ruangan ini disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan / sambungan langsung tanpa pengamanan arus.
 - e. Disediakan outlet oksigen, udara tekan medis dan udara tekan instrumen, vakum medik dan N_2O , beserta cadangannya yang memenuhi persyaratan.
 - f. Persyaratan Tata Udara adalah:
 - 1) Tekanan udara dalam ruangan lebih besar / positif dari ruangan-ruangan yang bersebelahannya.

- 2) Temperatur ruangan 19°-24°C.
 - 3) Kelembaban relatif 40-60%.
 - 4) Total pertukaran udara minimal 4 kali per jam pada saat ruangan tidak digunakan, dan 20 kali per jam pada saat ada operasi.
 - 5) Ruangan ini merupakan ruangan steril dengan hepa filter (tingkat resiko sangat tinggi), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 35.200 partikel (ISO 6-ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999) Intensitas cahaya minimal 200 lux.
 - 6) Meja operasi berada dibawah aliran udara laminair, dengan distribusi udara dari langit-langit, dengan gerakan ke bawah menuju inlet pembuangan (*return air*) yang terletak di 4 sudut ruangan yang dibuat plenum.
 - g. Persyaratan Kelistrikan :
 - 1) Sumber daya listrik, termasuk katagori “sistem kelistrikan esensial 3”, di mana sumber daya listrik normal dilengkapi dengan sumber daya listrik darurat untuk menggantikannya, bila terjadi gangguan pada sumber daya listrik normal.
 - 2) Sistem pembumian harus menjamin tidak ada bagian peralatan yang dibumikan melalui tahanan yang lebih tinggi dari pada bagian lain peralatan yang disebut dengan sistem penyamaan potensial pembumian (*Equal potential grounding system*). Sistem ini memastikan bahwa hubung singkat ke bumi tidak melalui pasien.
10. Ruang Pemulihan
- a. Bahan daun pintu masuk tahan terhadap benturan brankar, arah bukaan pintu ke dalam.
 - b. Kapasitas tt 1.5 kali dari jumlah ruangan operasi, dengan perhitungan luas per-tt minimal 8 m²
 - c. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.
 - d. Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan / sambungan langsung tanpa pengamanan arus.
 - e. Harus disediakan outlet oksigen.
 - f. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.
 - g. Intensitas cahaya 200 lux.
 - h. Ruangan ini merupakan ruangan dengan prefilter (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999).
11. Gudang Steril
- Ruangan ini merupakan ruangan zona resiko sedang.
12. Ruang Obat dan Ruang Perbekalan
- a. Dilengkapi kotak kontak untuk kebutuhan *medical refrigerator*.
 - b. Ruangan ini merupakan ruangan dengan prefilter (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999).
13. Ruang Penyimpanan Alat Bersih / Steril
- Ruangan ini merupakan zona risiko sedang.
14. Ruang Sterilisasi
- a. Ruangan ini merupakan ruangan zona resiko sedang.
 - b. Luas ruangan minimal dapat menampung *autoclave*.
 - c. Tersedia kotak kontak untuk peralatan *autoclave*.

15. Ruang Ganti / Loker

- a. Dibedakan antara loker pria dan wanita.
- b. Akses masuk dan keluar petugas berbeda.
- c. Dilengkapi toilet dan kamar mandi.
- d. Ruang ini merupakan ruangan dengan prefilter (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. $0,5\ \mu\text{m}$ per m^3 yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999).

16. Ruang Dokter

Ruang ini merupakan ruangan resiko sedang dengan prefilter.

17. Ruang Diskusi Medis

Ruang ini merupakan ruangan resiko sedang dengan prefilter.

18. Gudang Kotor (*Spoelhoek/ Dirty Utility*).

- a. Dilengkapi dengan *sloop sink* dan *service sink*.
- b. Letak ruang *spoelhoek* terhubung dengan koridor kotor.
- c. Persyaratan ventilasi udara:
 - 1) Tekanan udara dalam ruangan negatif.
 - 2) Total pertukaran volume udara minimal 10 kali per jam.
 - 3) Ruang ini merupakan ruangan resiko rendah, yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. $0,5\ \mu\text{m}$ per m^3 yaitu $>3.520.000$ partikel (ISO 9 - ISO 14644-1 *cleanroom standards*, 1999).

C. Peralatan

1. Ruang Persiapan

- a. Stetoskop.
- b. Tensimeter anaeroid.
- c. Tensimeter digital.
- d. Bed side monitor/ patient monitor.
- e. Film viewer 2 slides.
- f. Suction pump portable.
- g. Oxygen saturatie.

2. Kamar Bedah

- a. *Operating table*.
- b. *Mayo table*.
- c. *Operating lamp ceiling type*.
- d. Lampu periksa.
- e. ETT, LMA, nasotracheal dewasa dan pediatric.
- f. *Laryngoscope set* (Dewasa dan Pediatric).
- g. Fiber optic.
- h. Mesin anastesi.
- i. Defibrilator.
- j. Ventilator anastesi.
- k. Autoklaf.
- l. Mastektomi set.
- m. Infusion pump.
- n. Suction pump.
- o. Patient monitor.
- p. Patient stracher.
- q. Syringe pump.

3. *Recovery Room*

- a. Bed side monitor.
- b. Patient stracher.
- c. Defibrilator.
- d. *Emergency trolley*.

- e. Infusion pump.
- f. Suction pump.
- 4. Anastesi
 - a. *Circuit system* mesin anastesi
 - 1) Mesin anastesi sederhana.
 - 2) Mesin anastesi standar.
 - b. *Open system*
 - 1) Jackson rees (dewasa, anak dan neonatus).
 - c. Perlengkapan life support tindakan anastesi
 - 1) *Airway*
 - a) Laryngoscope set (dewasa, anak/bayi)
 - b) Laryngoscope McCoy
 - c) Nasopharyngeal tube
 - d) Oropharyngeal tube
 - e) Endotracheal tube/ ETT (dewasa, anak/bayi)
 - f) Stylet
 - g) Magill Forcep (dewasa, anak)
 - h) Mouth spreader
 - i) Suction apparatus
 - 2) *Breathing*
 - a) Masker anes/ BVM (face mask) (dewasa, anak/bayi)
 - b) Laryngeal mask / LMA
 - c) Bag valve mask / BVM bayi, anak, dewasa
 - d) Simple mask anak, dewasa
 - e) Oksigen tank transport small size
 - 3) *Circulation*
 - a) Defibrillator
 - b) Syringe pump
 - c) Infusion pump
 - d) Infusion pressure bag
 - e) Infuse warmer
 - f) Standart infuse
 - g) Timbangan darah
- D. Monitoring Tindakan Anastesi
 - 1. Bedside monitor
 - a. Monitor sederhana
 - b. Monitor standart
 - 2. Monitor saturasi oksigen
 - a. Pulse oxymeter
 - 3. Monitor end tidal co2
 - a. capnometer
 - 4. Monitor tekanan darah
 - a. Tensimeter
 - 5. Monitor fungsi paru (pemeriksaan suara nafas)
 - a. Stetoscope
- E. Alat Penunjang Tindakan Anastesi
 - 1. Untuk SAB / Regional Anastesi/ CVC
 - a. SAB- doek sterile set
 - 2. Untuk Nerve Blok/ Regional Anastesi
 - a. Nerve stimulator
 - 3. Ukur cara manuill VT mesin anastesi
 - a. Spirometer manuill
 - 4. Untuk vena seksi/ pasang cvp
 - a. Hechting set

- 5. Untuk operasi-operasi neonatus/ bayi
 - a. Infant warmer
- F. Alat Tambahan Tindakan Anastesi
 - 1. Sumber oksigen dari udara bebas
 - a. Oxygen concentrator

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Kemampuan Pelayanan Bedah Umum

1. SMF Bedah Umum terdiri dari 3 Operator yaitu
 - a. dr. Zaki Yamani Sp. B
 - b. dr. Djanuar Fitriadi Sp. B
 - c. dr. Angga Prawira Purwantoro, Sp. B
2. Jenis dan kemampuan pelayanan pada SMF Bedah Umum terdiri dari :
 - a. Appendectomy
 - b. Laparotomy
 - c. Repair
 - d. Herniotomy
 - e. Debridement
 - f. Excisi dan Incisi Biopsi
 - g. Excisi dan Incisi Drainage
 - h. Hemoroidectomy
 - i. Cholelithectomy
 - j. Istumobectomy
 - k. Thyroidectomy
 - l. Parsial Salpingotomy
 - m. Mastectomy
 - n. Orchiectomy
 - o. Hydrocelectomy
 - p. Ekstirpasi
 - q. Varicocelectomy
 - r. Amputation
 - s. Adhesiolysis
 - t. Reposition

4.2 Kemampuan Pelayanan Obstetri dan Gynecology

1. SMF Obstetri dan Gynecology terdiri dari 3 Operator yaitu :
 - a. dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG
 - b. dr. Agung Wijaya Kusuma Sp. OG
 - c. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG
2. Jenis dan kemampuan pelayanan pada SMF Obstetri dan Gynecology terdiri dari :
 - a. Sectio Caesarea
 - b. Sectio Caesarea dan MOW
 - c. Sectio Caesarea dan Pemasangan IUD
 - d. Curettage
 - e. Hysterectomy
 - f. SVH / TAH-BSO / SOD
 - g. Kistectomy
 - h. Laparotomy
 - i. Repair
 - j. Excisi
 - k. Parsial Salpingotomy
 - l. Tubectomy
 - m. Ovaryectomy
 - n. Debridement
 - o. Laparoscopic Salpingectomy

4.3 Kemampuan Pelayanan Orthopedi

1. SMF Orthopedi terdiri dari 2 Operator yaitu :
 - a. dr. Arianto Prabowo Sp.OT
 - b. dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT
 - c. dr. Fiski Purwantoro Sp. OT
2. Jenis dan kemampuan pelayanan pada SMF Orthopedi terdiri dari :
 - a. ORIF (*Open Reduction Internal Fixation*)
 - b. OREF (*Open Reduction External Fixation*)
 - c. Remove Implant
 - d. Close Reduction
 - e. Ostectomy / Partial Ostectomy
 - f. Release / Repair
 - g. Rekonstruktion
 - h. Joint Division
 - i. Amputatum
 - j. Squestectomy
 - k. Pull Thickness Skin Graft
 - l. Osteoplasti Bone Graft
 - m. Acomnionplasti
 - n. Transfixing
 - o. Adv. Flap
 - p. Adhesiolisis
 - q. Debridement
 - r. Pro Artrotomy
 - s. Sutury Artery
 - t. Bipolar
 - u. Spine

4.4 Kemampuan Pelayanan Urologi

1. SMF Urologi terdiri dari 1 Operator yaitu :
 - a. dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp. U
2. Jenis dan kemampuan pelayanan pada SMF Urologi terdiri dari :
 - a. TURP (*Transurethral Resection of the Prostate*)
 - b. URS (*Ureteroscopic Lithotripsy*)
 - c. ESWL (*Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*)
 - d. AFF DJ Stent
 - e. Vesikolitotripsi
 - f. Litotripsi
 - g. Uretroskopi
 - h. Sistoscopy
 - i. Sache
 - j. Circumcisi
 - k. PCNL (*Percutaneous Nephrolithotomy*)
 - l. Varicocelelectomy
 - m. Vesikolithotomy
 - n. Rekonstruktion
 - o. Hidrokelectomy
 - p. Orchidectomy
 - q. Sistostomy
 - r. Debridement

4.5 Kemampuan Pelayanan Bedah Plastik

1. SMF Bedah Plastik terdiri dari 1 Operator yaitu :

- a. dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K)
 - 2. Jenis dan kemampuan pelayanan pada SMF Bedah Plastik terdiri dari :
 - a. ORIF (*Open Reduction Internal Fixation*) / Platting
 - b. Excisi
 - c. Repair
 - d. Remove Implant
 - e. Pasang Archbar
 - f. Debridement
 - g. Skin Graft
 - h. Adv. Flap
 - i. Rekonstruksi
 - j. Reposisi
 - k. Tutup Defek
 - l. Orif
- 4.6 Kemampuan Pelayanan Bedah Saraf :
- 1. SMF Bedah Saraf terdiri dari 1 Operator yaitu :
 - a. dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS
 - 2. Jenis dan kemampuan pelayanan pada SMF Bedah Saraf terdiri dari :
 - a. Kraniotomi
 - b. EVD (*External Ventricular Drain*)
 - c. Repair
 - d. Excisi dan Incisi
 - e. Debridement
 - f. Adv. Flap
 - g. Debridement
 - h. Trepanasi
- 4.7 Kemampuan Pelayanan Mata
- 1. SMF Mata terdiri dari 2 Operator yaitu :
 - a. dr. Nurhadi Sutanto, Sp. M
 - b. dr. Indra Bayu, Sp.M
 - c. dr. Latifa Sp. M
 - 2. Jenis dan kemampuan pelayanan pada SMF Mata terdiri dari :
 - a. Phaco Katarak
 - b. Excisi
 - c. Od Ekstirpasi + Graf
 - d. Os Iridektomy
 - e. Debridement
 - f. Irigasi
 - g. Extrasi corpa
 - h. Graft
- 4.8 Kemampuan Pelayanan Dermatologi, Venereologi, dan Estetika
- 1. SMF DVE terdiri dari 2 operator
 - a. Excisi
 - b. Electrocouter curetage
 - c. Ekstirpasi

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 ALUR KAMAR OPERASI

A. Alur Masuk Petugas

1. Petugas Instalasi Kamar Operasi masuk lewat pintu masuk petugas kamar operasi, menempatkan sepatu / sandal dari luar pada tempat yang telah disediakan selanjutnya mengenakan baju, penutup kepala, masker serta sepatu boot / sandal operasi
2. Petugas selanjutnya melakukan kegiatan persiapan perlengkapan operasi, meliputi penyiapan peralatan bedah, pembersihan ruang bedah, mensterilkan ruang bedah dengan menyeka meja bedah, lampu bedah, mesin anastesi dan lainnya dengan cairan atau lap yang sesuai.
3. Set peralatan bedah diambil dari ruang penyimpanan steril, dan disiapkan di atas troli bedah.
4. Setelah siap, dokter bedah akan memeriksa kembali seluruh peralatan bedah yang siap dipergunakan, dan mengujinya bila diperlukan. Serta dokter bedah memeriksa kembali area tubuh yang akan dilakukan operasi dan dipastikan telah dilakukan penandaan pada area tubuh tersebut.
5. Di ruang dokter, dokter bedah beserta tim termasuk dokter anastesi melakukan koordinasi tindakan bedah yang akan dilakukan terhadap pasien, termasuk kemungkinan buruk yang bisa terjadi.
6. Selesai melakukan koordinasi dokter bedah memeriksa dan menguji apakah seluruh peralatan sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pembedahan.
7. Dokter anastesi, memeriksa peralatan mesin anastesi apakah sudah berfungsi dengan baik, termasuk zat anastesi yang akan digunakan.
8. Setelah semua siap perawat sirkuler menyalakan lampu indikator kegiatan operasi.
9. Dokter bedah dan tim bedah yang membantu operasi, sebelum melakukan pembedahan, mencuci tangan (*scrubbing*) terlebih dahulu di tempat cuci tangan.
10. Dokter dan tim bedah selanjutnya masuk ke ruang operasi untuk melakukan pembedahan. Sebelum melakukan pembedahan dokter dan tim bedah melakukan proses memakai baju / gaun operasi (*gowning*), memakai handscoon steril (*gloving*) kemudian melakukan desinfeksi dan sterilisasi area yang akan dioperasi (*drapping*)
11. Dokter bedah melakukan penyesuaian meja operasi dan lampu operasi yang lebih nyaman, demikian pula dengan posisi troli peralatan operasi.
12. Selesai melakukan operasi, dokter bedah beserta *tim bedah* kembali mencuci tangan dan dokter bedah kembali ke ruang dokter untuk membuat laporan.

B. Alur Masuk untuk Pasien

1. Pasien, umumnya dibawa dari ruang rawat inap menuju ruang operasi menggunakan *drag bar* atau kursi roda tanpa menggunakan atau membawa alas kaki.
2. Perawat ruang rawat inap, sesuai jadwal operasi 1 jam sebelum membawa pasien ke ruang pre operatif untuk dicocokkan identitasnya, apakah sudah sesuai dengan data yang sebelumnya dikirim ke ruang operasi dan sudah dipelajari oleh dokter yang bersangkutan. Pengantar pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu pengantar.
3. Perawat ruang atau instalasi gawat darurat memastikan untuk memasukkan Premedikasi sesuai advice dokter ahli bedah.

4. Di ruang pre operatif pasien dipindahkan dari drag bar / kursi roda ke tempat tidur pasien.
 5. Pasien dibersihkan, misalnya dicukur pada bagian rambut yang akan dioperasi, atau dibersihkan bagian-bagian lain yang dianggap perlu.
 6. Pasien diperiksa kembali kondisi tubuhnya meliputi tanda-tanda vital, kondisi alergi disekitar tubuh jika ada dan sebagainya.
 7. Apabila kondisi tubuh pasien cukup layak untuk dioperasi, pasien selanjutnya masuk ke ruang bedah untuk dilakukan operasi pembedahan.
 8. Selesai pembedahan pasien yang masih dipengaruhi oleh bius dari zat anastesi, selanjutnya dibawa ke ruang pemulihan RR (*Recovery Room*). Ruang ini sering juga dinamakan ruang PACU (*Post Anesthesi Care Unit*). Bila dianggap perlu, pasien bedah dapat juga langsung dibawa ke ruang perawatan intensif (ICU).
 9. Apabila pasien post operasi bedah kondisinya telah memenuhi standart pemulihan pasien sesuai jenis anastesi, maka pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat inap.
- C. Alur Linen Bersih
1. Linen bersih terdiri dari baju tim operasi masuk melalui pintu masuk petugas kamar operasi, sedangkan baju pasien dan sebagainya masuk melalui pintu pre operasi serta dibawa dengan menggunakan tempat khusus linen bersih yang tertutup.
 2. Linen disimpan pada almari yang tertutup.
- D. Alur Linen Kotor
1. Linen infeksius diletakkan pada kresek kuning dan ditali rapat.
 2. Linen dibawa ke binatu melalui pintu lorong belakang dan dimasukkan ke dalam jendela khusus yang menghubungkan Instalasi Kamar operasi dengan Instalasi binatu.
- E. Alur Instrumen dan Linen Steril
1. Instrumen dan Linen steril dari Instalasi Sterilisasi / CSSD dibawa masuk ke kamar operasi melalui jendela alat instrument / linen steril yang telah ada di koridor kamar operasi.
 2. Instrumen dan Linen steril disimpan pada almari alat steril dan disesuaikan dengan jenisnya.
- F. Alur Instrumen Infeksius
1. Instrumen infeksius dibawa ke unit steril dengan menggunakan tempat tertutup.
 2. Instrumen infeksius diletakkan pada jendela kecil disetiap kamar operasi dan akan diambil oleh petugas CSSD / Unit sterilisasi melalui lorong belakang / janitor menuju pintu keluar alat infeksius.

5.2 MANAJEMEN PRE OPERATIF

Durasi operasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Emergensi** : Prosedur yang mengancam nyawa atau tungkai dan harus selesai dikerjakan dalam 30 menit.
2. **Prioritas** : Prosedur yang harus dikerjakan dalam 30 menit sampai 4 jam.
3. **Urgent** : Prosedur yang harus dikerjakan dalam 4 jam sampai 24 jam.
4. **Non-urgent** : Prosedur yang bisa dikerjakan setelah 24 jam. Dalam kaitannya dengan kamar operasi yang diperuntukkan untuk kejadian *urgent*, hanya kasus emergensi, prioritas, dan *urgent* yang diperkenankan menggunakan kamar tersebut. Untuk itu, petugas penjadwalan kamar operasi perlu dibekali pengetahuan khusus / pelatihan mengenai hal ini.

A. Memonitor Performa Kamar Operasi / Ruang Tindakan

Sebelum prosedur dimulai, harus dilakukan persiapan ruangan. Hal ini meliputi menciptakan lapangan steril, menyiapkan alat-alat, dan memeriksa kelengkapannya.

1. Penciptaan lapangan steril:

- a. menempatkan duk steril di sekeliling area operasi dan pada tempat alat-alat.
- b. Semua personel harus mengenakan pakaian / gown steril.
- c. Hanya alat steril dan orang-orang yang telah steril yang diperbolehkan memasuki lapangan steril.
- d. Jangan menempatkan alat-alat steril di dekat pintu yang terbuka.
- e. Jendela harus ditutup.
- f. Letakkan alat steril hanya pada lapangan steril.
- g. Pastikan tangan telah *discrub* sebelum menyentuh alat steril.
- h. Orang yang telah steril tidak diperkenankan menyentuh alat-alat tidak steril atau pergi ke tempat yang tidak steril.
- i. Perlu diingat bahwa ujung kemasan dari alat-alat steril adalah tidak steril.
- j. Perlu diingat bahwa sekali batas steril telah dilewati, hal ini telah dianggap terkontaminasi.
- k. Jika ada keraguan tentang status sterilitas sesuatu alat atau area, harus dianggap telah terkontaminasi.

2. Persiapan alat:

Ada empat tahap proses persiapan alat, yaitu: pencucian dan dekontaminasi, desinfeksi, sterilisasi, dan penyimpanan atau pemindahan ke lapangan steril. Ada beberapa jenis sterilisasi, yaitu menggunakan *steam*, *ethylene oxide*, *ozone*, dan gas plasma.

3. Persiapan perlengkapan anestesi

4. Memastikan kualitas udara dan ventilasi:

- a. Ventilasi kamar operasi harus *positive-pressure*.
- b. Udara harus masuk ke ruangan melalui ventilasi langit-langit yang tinggi dan keluar dari ruangan melalui *exhaust air outlet* dekat lantai yang berseberangan dengan ventilasi masuk.
- c. Mengatur agar sedikitnya terjadi 15 kali pertukaran udara per jamnya, di mana 3 di antaranya harus udara segar.
- d. Penyaringan udara yang diresirkulasi dan udara segar melalui filter yang baik dengan efisiensi minimum 90%.
- e. Ruangan hanya diijinkan dibuka untuk perpindahan alat, personel tim bedah, dan pasien; selebihnya pintu dijaga agar selalu tertutup.

5. Mengatur lalu-lintas:

Zona dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Unrestricted zone*: hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh berada di zona ini, tetapi baju luar biasa diperbolehkan.
- b. *Semirestricted zone*: zona ini adalah area yang terhubung dengan kamar operasi (contohnya: lorong, kantor, kamar alat), orang-orang yang berada di sini harus mengenakan pakaian *scrub* dengan lengan panjang, penutup rambut, dan sepatu bersih atau penutup sepatu.
- c. *Restricted zone*: zona ini terdiri dari kamar operasi dan area cuci tangan, orang-orang yang memasuki zona ini harus mengenakan kostum bedah lengkap termasuk masker. Mereka yang tidak *discrub* harus mengenakan jaket berlengan panjang lengkap dengan kancing tertutup. Masker khususnya harus dikenakan di ruangan dengan peralatan steril yang terbuka.

*Pastikan bahwa semua alat-alat yang diperlukan telah siap tersedia di dalam kamar operasi sebelum prosedur dimulai untuk meminimalkan lalulintas yang tidak perlu dari dan ke dalam ruangan.

B. Manajemen Pasien

Beberapa poin penting dalam mengkaji faktor risiko pasien:

1. Alergi.
2. Riwayat kesehatan sebelumnya (misalnya tekanan darah tinggi, asma, masalah jantung atau pernapasan).
3. Penggunaan tembakau (karena rokok meningkatkan risiko infeksi).
4. Penggunaan alkohol dan narkotika.
5. Pengalaman pribadi pasien dengan sedasi dan anestesi sebelumnya.
6. Berat badan.
7. Obat-obatan yang dikonsumsi saat ini.
8. Ada tidaknya risiko untuk anestesi dan sedasi.
9. Permintaan khusus dari pasien untuk jenis anestesi dan sedasi.
10. Kecemasan pasien.
11. Delirium.
12. Status nutrisi.
13. Risiko potensial untuk *deep vein thrombosis*

C. Manajemen Tim Bedah

1. Rekomendasi standar:

- a. Kostum bedah harus terbuat dari bahan yang ringan dan memungkinkan untuk bernapas. Kostum tidak terbuat dari kapas karena kapas mudah terbakar dan memiliki banyak pori yang bisa dilewati mikroorganisme.
- b. Sepatu proteksi harus tertutup bagian depannya, bertumit rendah, bersol anti selip, dan dibersihkan secara berkala.
- c. Sebelum memegang kostum bedah atau memasuki tempat kostum bedah, semua personel harus mencuci tangan dengan sabun dan air, antiseptik dan air, atau antiseptic hand rub.
- d. Kostum bedah harus diganti setiap harinya atau setiap kali terkontaminasi atau basah. Bila kostum terdiri dari 2 bagian, atasan harus selalu dimasukkan ke dalam bawahan dan ukuran harus pas.
- e. Semua personel harus menutupi kepala dan rambut muka.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu yang berisiko terciprat (misalnya kasus trauma), tim bedah harus mengenakan alat-alat proteksi tambahan. Masker harus menutupi seluruh bagian mulut dan hidung.
- g. Kostum bedah harus dilaundry di fasilitas laundry yang terakreditasi.
- h. Seluruh personel harus menerima edukasi dan pengarahan perihal kostum bedah ini.

2. Beberapa prinsip penggunaan sarung tangan:

- a. Sarung tangan harus menjadi *barrier* yang efektif terhadap material infeksius, termasuk darah dan cairan tubuh.
- b. Sarung tangan harus diganti setiap habis kontak dengan pasien atau setiap sarung tangan tersebut rusak.
- c. Sarung tangan tidak boleh dicuci atau direuse.
- d. Untuk prosedur invasif, tenaga kesehatan harus memakai dua lapis sarung tangan, satu di atas yang lain.

D. *Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery*

Beberapa hal yang berpotensi untuk menimbulkan kekeliruan untuk *wrong surgery*:

1. Lebih dari satu dokter bedah terlibat.
2. Dilakukan lebih dari satu prosedur.
3. Pasien memiliki beberapa karakteristik khusus, seperti deformitas fisik atau obesitas massif.

4. Ada beberapa pasien yang memiliki nama yang sama atau prosedur yang sama atau di waktu yang bersamaan.

Tiga komponen penting protokol, yaitu:

1. Proses verifikasi.
2. Menandai lokasi yang akan dilakukan operasi
3. *Time out*

E. *Surgical Safety Checklist*

Ada 3 periode terpenting :

1. Sebelum Induksi (*sign in*)

Langkah pertama yang dilakukan segera setelah pasien tiba di ruang serah terima sebelum dilakukan induksi anestesi. Tindakan yang dilakukan adalah memastikan identitas, lokasi/area operasi, prosedur operasi serta persetujuan operasi. Pasien atau keluarga diminta secara lisan untuk menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir dan tindakan yang akan dilakukan. Penandaan lokasi operasi harus sudah dilakukan oleh operator ahli bedah yang akan melakukan operasi. Pemeriksaan keamanan anestesi oleh ahli anestesi dan harus memastikan kondisi pernapasan, risiko perdarahan,antisipasi adanya komplikasi, dan riwayat alergi pasien. Memastikan peralatan anestesi berfungsi dengan baik, ketersediaan alat, dan obat-obatan.

2. Sebelum Insisi (*time out*)

Merupakan langkah kedua yang dilakukan pada saat pasien sudah berada di ruang operasi, sesudah induksi anestesi dilakukan dan sebelum ahli bedah melakukan sayatan kulit. Untuk kasus pada satu pasien terdapat beberapa tindakan dengan beberapa ahli bedah *time out* dilakukan tiap kali pergantian operator. Tujuan dilakukan *time out* adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan pasien, lokasi dan prosedur pembedahan dan meningkatkan kerjasama antara anggota tim bedah, komunikasi diantara tim bedah dan meningkatkan keselamatan pasien selama pembedahan. Seluruh tim bedah memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan peran masing-masing. Menegaskan lokasi dan prosedur pembedahan, dan mengantisipasi risiko. Ahli bedah menjelaskan kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi ahli anestesi menjelaskan hal khusus yang perlu diperhatikan. Tim perawat menjelaskan ketersediaan dan kesterilan alat. Memastikan profilaksis antibiotik sudah diberikan. Memastikan apakah hasil radiologi yang ada dan diperlukan sudah ditampilkan dan diverifikasi oleh 2 orang.

3. Sebelum Keluar Kamar Operasi (*sign out*)

Merupakan tahap akhir yang dilakukan saat sebelum penutupan luka operasi. Koordinator memastikan prosedur sesuai rencana, kesesuaian jumlah alat, kasa, jarum, dan memastikan pemberian etiket dengan benar pada bahan-bahan yang akan dilakukan pemeriksaan patologi.

5.3 MANAJEMEN INTRAOPERATIF

A. Monitor Pasien

1. Monitoring Anestesi dan Sedasi

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh tim bedah:

- a. Mengkomunikasikan risiko sebelum memulai prosedur.
- b. Memastikan kompetensi yang meliputi: memasukkan obat sesuai level anestesi yang diminta, memonitor pasien untuk mempertahankan level anestesi, memberhentikan anestesi dan menyelamatkan pasien jika mereka masuk 'terlalu dalam'.
- c. Menyiapkan obat-obatan emergensi dan antidotum.
- d. Mempersiapkan efek-efek samping obat (*medication error*).

- e. Memantau tanda-tanda vital (tekanan darah, frekuensi denyut jantung dan ritme, frekuensi pernapasan, saturasi oksigen, akses intravena yang adekuat, nyeri).
 - f. Mempertimbangkan pemanfaatan teknologi untuk teknik anestesi.
 - g. Menggunakan mnemonic:
C irculation, *capnograph*, *color* (saturasi)
O ksigen
V entilasi dan vapisasi
E ndotracheal tube
R eview monitor dan peralatan
A irway
B reathing
C irculation
D rugs
A wareness
S wift check (pasien, dokter bedah, proses, dan respons)
 - h. *Awareness* anestesi: kasus-kasus di mana pasien bangun di tengatengah anestesi (intraoperatif)
 - 1) Mengidentifikasi pasien-pasien berisiko.
 - 2) Perawatan peralatan
 - 3) *Monitoring* pasien
2. Memasukkan Obat
- Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko:
- a. Mengidentifikasi pasien dan mengkonfirmasi alergi obat yang dimiliki.
 - b. Memverifikasi obat sebelum pemberian obat.
 - c. Menggunakan perintah verbal terstruktur.
 - d. Mengidentifikasi penggunaan obat-obatan *high-alert*.
 - e. Menstandarisasi preparasi obat-obat yang dilarutkan agar siap digunakan.
 - f. Menghindari pelarutan obat di lapangan operasi, pelarutan obat-obatan sebisa mungkin digunakan oleh apoteker terdaftar menggunakan hanya larutan *premixed*
 - g. Klinisi di ruang operasi harus mengkomunikasikan semua dosis obat yang akan dimasukkan dan mengklarifikasi dosis maksimal dengan dokter anestesi dan dokter bedah.
 - h. Mengedukasi perawat dan anggota lain yang bekerja di ruang operasi tentang penanganan dan pemberian obat-obat *high alert*.
 - i. mengkaji dan memvalidasi kompetensi klinis tentang penggunaan dan pemberian obat-obat *high alert*.
- Hal-hal lain yang perlu dimonitor secara ketat selama operasi:
- a. Kadar glukosa
 - b. Suhu tubuh
 - c. penggunaan darah
- B. Menghindari Masalah dalam Ruang Operasi
- Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari masalah dalam ruang operasi:
- 1. Meminimalkan *distraction* dan interupsi.
 - 2. Mencegah trauma benda tajam.
 - a. Keselamatan alat (skalpel yang terlindung, jarum berujung tumpul, dll)
 - b. Keselamatan teknik.
 - 1) Menggunakan zona netral di mana benda-benda tajam ditempatkan tanpa kontak tangan.
 - 2) Menggunakan teknik tanpa sentuh.
 - 3) Menggunakan sarung tangan dua rangkap.
 - 4) Mempertimbangkan penggunaan sarung tangan anti-robek.

- 5) Mengganti sarung tangan bedah secara rutin.
- 6) Menggunakan teknik jahit yang mencegah trauma.
- 7) Sebisa mungkin menghindari lapangan bedah ketika dokter bedah memotong dan menjahit.
- 8) Memakai alas kaki yang terlindung
- c. Program kontrol pajanan.
- d. Program edukasi.
3. Mencegah tertinggalnya benda-benda di dalam luka operasi dengan metode penghitungan alat-alat.
4. Menangani spesimen secara benar (meliputi kontainer dan alat pengambilan spesimen, identifikasi spesimen, labeling, transportasi spesimen, komunikasi, pembuangan spesimen).
5. Mencegah kebakaran:
 - a. Persiapan pasien.
 - b. Penggunaan alat-alat secara aman.
 - c. Persiapan alat-alat.
 - d. Membatasi bahan-bahan yang mudah terbakar.
 - e. Mengontrol oksigen.
 - f. Membagi tugas di antara anggota tim bedah mengenai pencegahan kebakaran.
 - g. Komunikasi efektif dan kerja tim.
 - h. Merespons bila terjadi kebakaran:
 - 1) Bagaimana memadamkan api secepatnya.
 - 2) Bagaimana menangani pasien.
 - 3) Bagaimana memindahkan pasien secara aman.
 - 4) Bagaimana evakuasi ruang operasi secara aman.
 - 5) Bagaimana mengaktifasi sistem keamanan kebakaran.
 - 6) Bagaimana mencegah penyebaran asap.
 - 7) Bagaimana menemukan dan menggunakan alat pemadam kebakaran.
 - 8) Bagaimana peran tim pemadam kebakaran dari luar.

5.4 MANAJEMEN *POSTOPERATIF*

A. Membersihkan Lingkungan Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pembersihan lingkungan operasi:

1. Pembuangan sisa-sisa bekas operasi.
2. Sisa patologi manusia yang meliputi jaringan, organ, bagian tubuh, dan cairan.
3. Darah manusia dan komponen darah yang meliputi serum, plasma, dan komponen darah.
4. Benda tajam.
5. Sisa-sisa alat atau benda yang terkontaminasi pasien.
6. Benda-benda tajam yang tidak terpakai.

Ketika menangani sisa-sisa bekas operasi, petugas yang bertugas mengumpulkan termasuk petugas kebersihan harus memakai alat pelindung diri untuk mencegah pajanan. Setelah sisa-sisa tersebut terkumpul, harus ditranspor ke area penyimpanan yang sesuai. Selama transpor harus diperhatikan bahwa benda terkontaminasi tidak kontak dengan alat steril. Untuk mencegah penyebaran infeksi, kereta pembawanya harus dibersihkan dan didesinfeksi sesuai jadwal.

B. Transportasi *Laundry* Terkontaminasi

Sebelum membersihkan ruangan, linen kotor harus diangkat terlebih dahulu. Tekstil, linen, dan kain terkontaminasi harus dipindahkan dengan kontak seminimal mungkin dengan udara, permukaan, dan personel dalam ruangan.

Sebelum memindahkan *laundry* dari permukaan, harus dipastikan benda tajam dan barang *nonlaundry* lainnya telah dipisahkan untuk memastikan keamanan transportasi dan trauma benda tajam. Dalam melipat linen, pastikan bagian terkontaminasi berada di tengah sehingga bagian yang bersih berperan sebagai *barrier* terhadap bagian yang kotor. *Laundry* terkontaminasi ditempatkan di kontainer berwarna merah atau yang bertanda *biohazard*. *Laundry* yang basah harus ditempatkan di kantong-kantong yang anti bocor. Dalam transportasi, personel *laundry* tidak boleh memegang kantong berisi *laundry* terkontaminasi dengan tubuhnya atau meremas kantongnya untuk mencegah tertusuk jarum atau benda tajam lain yang tanpa sengaja tertinggal.

C. Membersihkan Area Operasi

1. Kamar operasi minimal harus dibersihkan setiap 24 jam bila tidak ada kegiatan atau ruangan tidak dipakai.
2. Bila area terkontaminasi, maka kontaminasi harus dibersihkan/diangkat terlebih dahulu baru area dibersihkan dengan desinfektan karena banyak kontaminan menginaktivasi desinfektan.
3. Bila kontaminasi basah, luas, dan infeksius, maka harus diletakkan kain yang bisa menyerap cairan dan desinfektan dituang ke atas kain tersebut sampai semuanya basah terendam. Dapat juga digunakan bubuk penyerap yang memadatkan cairan
4. Bahan desinfektan terhadap darah dan cairan tubuh yang direkomendasikan adalah yang efektif terhadap virus hepatitis B dan HIV, tuberkulosis, dan yang cocok untuk segala jenis permukaan, misalnya berpori maupun non-pori.
5. Debu harus ditangani dengan menggunakan kain khusus debu atau alat pel yang mencegah terbangnya debu. Untuk area yang lebih tinggi dari bahu, petugas kebersihan harus menggunakan alat yang khusus didesain untuk permukaan tinggi. Alat pembersih debu tidak boleh digoyang-goyangkan karena spora jamur bisa beterbangan di udara.
6. Untuk menghindari terpeleset atau tersandung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
 - a. Area yang licin harus ditutup untuk sementara untuk semua karyawan, kecuali petugas kebersihan.
 - b. Tutup pintu dan tempatkan tanda dilarang masuk.
 - c. Mulai dari area yang paling bersih ke daerah yang paling kotor.
 - d. Gunakan wax atau alas bergerigi untuk menciptakan permukaan anti slip.
 - e. Pindahkan penghalang atau tanda-tanda dilarang masuk hanya setelah lantai kering sempurna.
 - f. Tim bedah harus menggunakan alas kaki anti slip.
 - g. Kaset harus tahan slip dan bila kaset tersaturasi oleh cairan, harus segera diganti.
 - h. Pastikan kabel-kabel tidak melintang di tengah jalan. Kabel harus dibundel sebaiknya di langit-langit jika memungkinkan.
 - i. Alat-alat dan monitor harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga akses jalan tidak terhalang dan lantai dapat terlihat.
 - j. Pencahayaan harus diatur dengan baik agar dapat melihat dengan jelas di dalam ruang operasi.

D. *Postoperative Care*

1. Mengkaji status mental pasien, dapat dilakukan dengan menanyakan kepada pasien:
 - a. Tanggal hari ini
 - b. Hari apa hari ini
 - c. Nama tempat ia berada saat ini

- d. Nomor teleponnya
 - e. Nama jalan tempat tinggalnya
 - f. Berapa umurnya
 - g. Kapan ia dilahirkan
 - h. Siapa nama gadis ibu kandungnya
 - i. Berapa hasil 20 dikurang 3, lalu hasilnya dikurang 3 lagi, dst sampai beberapa kali
2. Mengkaji status fisik pasien, dapat dilakukan dengan memeriksa tanda vital, derajat nyeri, adanya pembengkakan, fungsi respirasi, *drainage* luka, efek samping anestesi, atau *deep vein thrombosis*
 3. Mengkaji obat-obatan yang dibutuhkan, hal ini meliputi obat-obatan apa yang harus diteruskan dari operasi, atau mana yang harus distop atau obat-obat baru, termasuk darah dan komponen-komponen darah yang diperlukan. Peresepan dan pemberian obat-obatan tersebut harus dicatat dengan baik sesuai urutannya, semua perintah verbal diulang kembali, dan dilabel secara benar. Dapat dipikirkan pemanfaatan teknologi komputer untuk pendokumentasian maupun pengingat.
 4. Mencegah infeksi (khususnya dari *surgical site*, kateter urin, dan akses intravena).
 - a. Monitor ketat suhu tubuh dan kadar glukosa darah untuk mengurangi risiko infeksi postoperatif dari *surgical site*
 - b. Gunakan kateter urin hanya bila diperlukan
 - c. Kurangi waktu penggunaan kateter urin, kateter harus sering diganti secara berkala.
 - d. Gunakan teknik yang benar untuk insersi dan perawatan.
 - e. Catat semua penggunaan kateter urin.
 - f. Berikut ini contoh *checklist* untuk insersi akses sentral.
- E. Proses Pemulangan Pasien
- Beberapa poin kunci dalam pemulangan pasien:
1. Komunikasi sedini mungkin dan sesering mungkin dengan pasien.
 2. Koordinasi proses pemulangan (bukan hanya di hari terakhir, tetapi selama perawatan di rumah sakit).
 3. Mengatur proses secara sistematis.
 4. Melibatkan pasien dalam proses perencanaan pemulangan.
 5. Edukasi pasien dan keluarganya.
 6. Berbagi sumber dengan pasien, misalnya tentang layanan rumah pemesanan makanan dan transportasi di komunitas.
 7. Membuat perjanjian dengan pasien dan keluarganya, bila memungkinkan, untuk *follow up*. Berikan catatan berisi nama, alamat, dan telepon yang bisa dihubungi.
 8. Rekonsiliasi pengobatan, lakukan *double-check* untuk obat-obatan terakhir yang diberikan untuk di rumah. Berikan kepada pasien daftar obat-obat yang akan ia konsumsi di rumah, daftar tersebut harus mencakup deskripsi obat, indikasi, dosis, jadwal pemberian, dan efek samping yang mungkin ditimbulkan. Hal ini bersama dengan pengertian pasien harus selalu direkonfirmasi oleh tenaga kesehatan. Pasien dianjurkan untuk selalu membawa daftar obatnya, termasuk ketika kontrol berobat.
 9. Kolaborasi dengan layanan komunitas.

BAB VI
LOGISTIK

Tabel 6.1 Daftar Logistik yang terdapat di Instalasi Kamar Operasi Rumah Sakit Prima Husada

No.	Jenis Logistik	Uraian
1.	Floorstock	Baca panduan floorstock rumah sakit.
2.	Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Baca Daftar Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit Prima Husada
3.	Alat Tulis dan Kantor	▪ Buku tulis ▪ Lem ▪ Isolasi kertas ▪ Isolasi bening ▪ Stapples ▪ Pelubang kertas ▪ Isi steaples ▪ Gunting ▪ Spidol Boardmarker ▪ Bolpoint hitam ▪ Bolpoint merah ▪ Stabilo ▪ Box file ▪ Penggaris ▪ Map
4.	Inventaris lain	▪ Plastik klip 11x7 cm ▪ Plastik klip 6x4 cm ▪ Plastik ½ kg ▪ Plastik 1 kg ▪ Sabun cuci tangan ▪ Sabun cuci piring ▪ Tissue kotak ▪ Kresek hitam ▪ Gunting ▪ Botol Handsrub
5.	Dokumen tertulis	▪ Resep ▪ RM pasien operasi ▪ Lembar permintaan pemeriksaan PA ▪ Lembar kuitansi operasi ▪ Lembar pemakaian implant
7.	Alat	▪ Alat medis: Baca Infentaris alat Medis Instalasi Kamar Operasi ▪ Alat non Medis: baca infentaris alat non medis instalasi kamar operasi

BAB VII KESELAMATAN PASIEN

7.1 PENGERTIAN KESELAMATAN PASIEN

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi : *assesment* resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, implementasi untuk mencegah meminimalkan timbulnya resiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

7.2 TUJUAN KESELAMATAN PASIEN

Tujuan sistem ini adalah mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Selain itu tujuan agar tercipta budaya keselamatan di rumah sakit, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunkan kejadian tidak diharapkan di rumah sakit dan terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan.

7.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

1. Enam Langkah Menuju Keselamatan Pasien.
 - a. Tepat Identifikasi Pasien.
 - b. Peningkatan Komunikasi yang efektif.
 - c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai.
 - d. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur dan tepat-pasien operasi.
 - e. Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
 - f. Pengurangan resiko pasien jatuh.
2. Standar Melaksanakan Keselamatan Pasien.
 - a. Hak pasien.
 - b. Mendidik pasien dan keluarga.
 - c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.
 - d. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.
 - e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien.
 - f. Mendidik karyawan tentang keselamatan pasien.
 - g. Komunikasi yang merupakan kunci bagi karyawan untuk mencapai keselamatan pasien.
3. Langkah-Langkah Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 - a. Menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab mengelola program keselamatan pasien rumah sakit.
 - b. Menyusun program keselamatan pasien rumah sakit jangka pendek.
 - c. Mensosialisasikan konsep dan program keselamatan pasien rumah sakit.
 - d. Mengadakan pelatihan keselamatan pasien rumah sakit bagi jajaran manajemen dan karyawan.
 - e. Menetapkan sistem pelaporan insiden (peristiwa keselamatan pasien).
 - f. Menetapkan enam langkah menuju keselamatan pasien.
 - g. Menetapkan standar keselamatan pasien rumah sakit dan melakukan shift assesmen dengan instrumen akreditasi pelayanan keselamatan pasien rumah sakit.
 - h. Program khusus keselamatan pasien.

- i. Mengevaluasi secara periodik pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit dan kejadian tidak diharapkan.
4. Sasaran Keselamatan Pasien
- Sasaran keselamatan pasien di instalasi kamar operasi Rumah Sakit Prima husada
1. Ketepatan identifikasi pasien
Ketepatan identifikasi pasien adalah ketepatan penentuan identitas pasien awal pasien masuk sampai dengan pasien keluar terhadap semua pelayanan yang diterima oleh pasien.
 2. Peningkatan komunikasi yang elektif
Komunikasi yang elektif adalah komunikasi lisan yang menggunakan *sistem write, read dan repeat back (reconfirm)*.
 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (*high –alert*)
Obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang memiliki resiko lebih tinggi yang dapat menyebabkan atau menimbulkan adanya komplikasi atau membahayakan secara signifikan terhadap kesalahan penggunaan.
 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
Salah lokasi, salah prosedur, salah pasien pada operasi merupakan hal yang menguatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit, kesalahan ini merupakan komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antar tim bedah, karena tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi (*site marking*) dan verifikasi lokasi operasi.
 - a. Penandaan area operasi di Rumah Sakit Prima Husada dilakukan oleh dokter operator, penandaan dilakukan pada waktu operator *visite* pra operasi, pada pasien dengan rencana operasi elektif. Sedangkan pada pasien operasi emergensi dilakukan penandaan di IGD atau di ruang pramedikasi sesaat sebelum pasien diinduksi.
 - b. Penandaan dilakukan dengan memberi tanda panah lingkaran ($\rightarrow O$) untuk mencegah terjadinya salah insisi pada pasien.
 - c. Beberapa hal yang berpontesi untuk menimbulkan kekeliruan untuk *wrong surgery*:
 - 1) Lebih dari satu dokter bedah terlibat.
 - 2) Dilakukan lebih dari satu prosedur operasi.
 - 3) Pasien memiliki beberapa karakteristik khusus, seperti deformitas fisik atau obesitas massif.
 - 4) Ada beberapa pasien yang memiliki nama yang sama atau prosedur yang sama atau diwaktu bersamaan.
 - d. Tiga komponen penting dalam mencegah terjadinya *wrong site, wrong procedure* dan *wrong person surgery* :
 - a) Proses verifikasi
 - b) Menandai lokasi yang akan dilakukan operasi
 - c) *Time out*
 - e. Lokasi operasi ditandai pada kasus operasi sisi (*laterality*), struktur multiple (jari tangan, jari kaki) atau level multiple (tulang belakang).
 - f. Tindakan operasi yang memerlukan penandaan antara lain :
 - 1) Operasi Spinal.
 - 2) Operasi mata.
 - 3) Operasi yang memiliki dua sisi.
 - 4) Penandaan area operasi pada mata dengan menggunakan kasa/*gause* yang ditutupkan pada mata yang akan dioperasi dengan memberi tanda ($\rightarrow O$) pada kassa.
 - g. Beberapa prosedur yang tidak memerlukan penandaan :
 - 1) kasus organ tunggal (jantung, operasi Sectio Caesaria, appendiktomi).

- 2) kasus intervensi seperti kateter jantung.
- 3) kasus yang melibatkan gigi.
- 4) prosedur yang melibatkan bayi premature di mana penandaan akan menyebabkan tato permanen.

Dalam kasus yang tidak dilakukan penandaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Penandaan harus dilakukan, dengan melibatkan pasien atau keluarga, untuk menghindarkan kekeliruhan. Penandaan dilakukan dengan spidol permanen yang tidak dapat hilang saat dicuci.

5. Pengurangan resiko infeksi pelayanan kesehatan
Infeksi biasa dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan termasuk saluran kemih, infeksi pada aliran darah, pneumonia yang sering terjadi pada pasien dengan ventilasi mekanis. Pokok eliminasi infeksi maupun infeksi –infeksi lain dengan cuci tangan.
6. Pengurangan resiko pasien jatuh
Jumlah kasus pasien jatuh cukup bermakna sebagai cedera pasien, sehingga Rumah Sakit Prima Husada melakukan evaluasi resiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi resiko cedera.

7.4 ALUR PELAPORAN INSIDEN KE TIM KESELAMATAN PASIEN (KP) DI RUMAH SAKIT

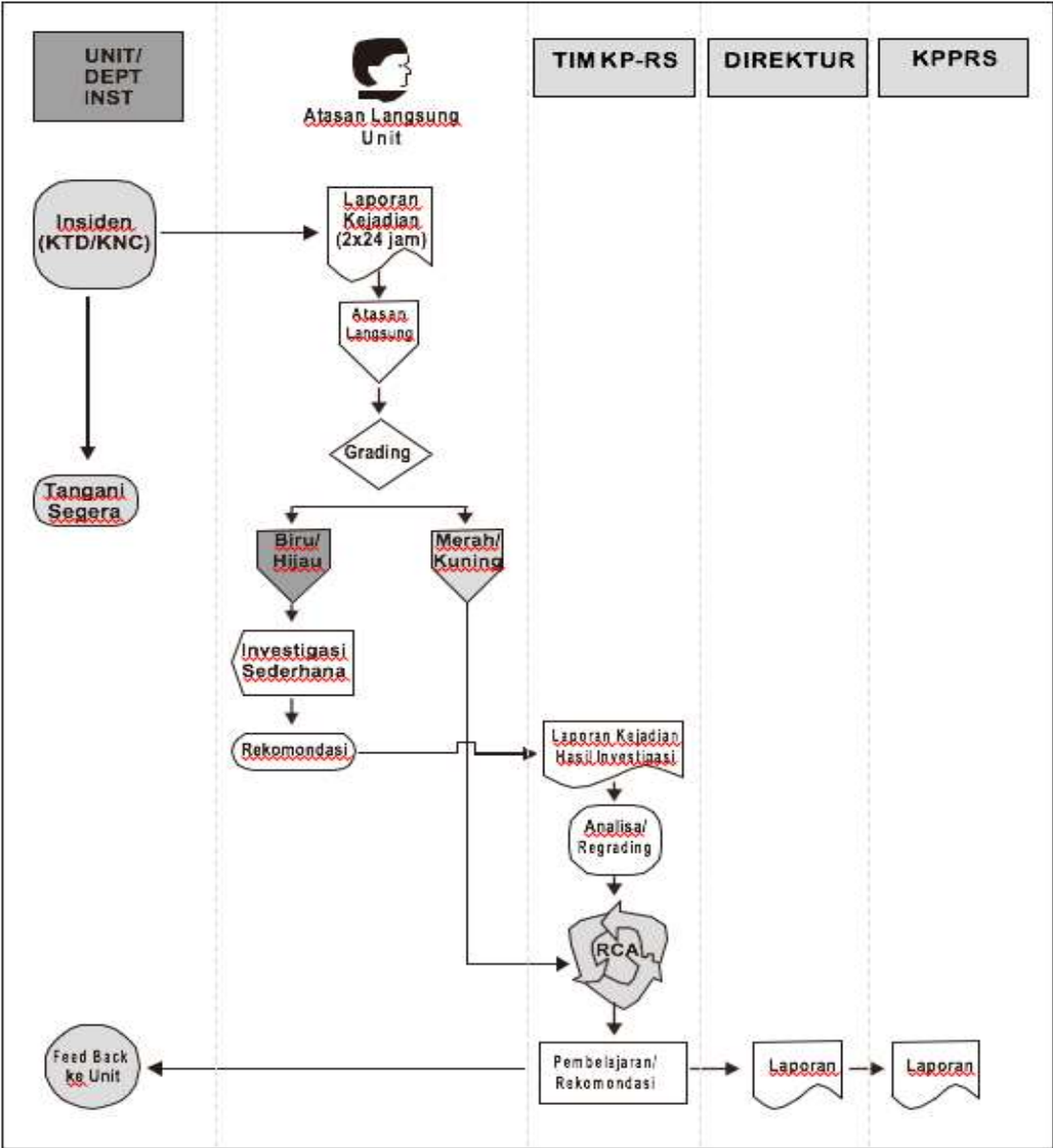
- A. Apabila terjadi suatu insiden (KNC/KTD/Kejadian Sentinel) terkait dengan pelayanan kamar operasi, wajib segera ditindaklanjuti (dicegah/ditangani) untuk mengurangi dampak/ akibat yang tidak diharapkan.
- B. Setelah ditindaklanjuti, segera buat laporan insidennya dengan mengisi Formulir Laporan Insiden pada akhir jam kerja/shift kepada penanggung jawab shift dan jangan menunda laporan (paling lambat 2 x 24 jam).
- C. Laporan segera diserahkan kepada kepala ruang.
- D. Kepala ruang memeriksa laporan dan melakukan *grading risiko* terhadap insiden yang dilaporkan.
- E. Hasil *grading* akan menentukan bentuk investigasi dan analisis yang akan dilakukan.
- F. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke Tim KP di RS.
- G. Tim KP di RS akan menganalisis kembali hasil investigasi dan Laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan *Root Cause Analysis* (RCA) dengan melakukan *Regrading*.
- H. Untuk Grade kuning/merah, Tim KP di RS akan melakukan *Root Cause Analysis* (RCA).
- I. Setelah melakukan *Root Cause Analysis* (RCA), Tim KP di RS akan membuat laporan dan Rekomendasi untuk perbaikan serta “pembelajaran” berupa : Petunjuk / *Safety alert* untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.
- J. Hasil *Root Cause Analysis* (RCA), rekomendasi dan rencana kerja dilaporkan kepada Direksi.
- K. Rekomendasi untuk “Perbaikan dan Pembelajaran” diberikan umpan balik kepada instalasi kamar operasi.
- L. Kepala ruang akan membuat analisis dan tren kejadian disatuan kerjanya.
- M. Monitoring dan Evaluasi Perbaikan oleh Tim KP di RS.

7.5 PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)

Tabel 7.1 Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

DATA PASIEN	
Nama Pasien	(bisa diisi initial misal: Tn. AR, atau NY. SY) No.RM: (jelas)

Ruangan	Diisi nama ruangan dan nomor kamar misal: R. Melati/301
Data Pasien	1. Umur (bulan dan tahun (jelas)). 2. Kelompok Umur (Pilih salah satu (jelas)). 3. Jenis Kelamin (Pilih salah satu (jelas)). 4. Penanggung biaya pasien (Pilih salah satu (jelas)). 5. Tgl/jam MRS (jelas). (lihat=Lampiran Formulir Laporan IKP).
Tanggal dan waktu insiden	1. Diisi tanggal dan waktu saat insiden (KTD/KNC/KTC/ KPC) terjadi. 2. Buat prosedur pelaporan agar tanggal dan waktu insiden tidak lupa: insiden harus dilaporkan paling lambat 1 x 24 jam atau pada akhir jam kerja/ shift.
Insiden	Salah identifikasi pasien, salah lokasi operasi, salah lokasi operasi dll.
Grading Risiko	hijau/biru/kuning/merah
Kronologis	1. Diisi ringkasan insiden mulai saat sebelum kejadian sampai terjadinya insiden. 2. Kronologis harus sesuai kejadian yang sebenarnya, bukan pendapat / asumsi pelapor.
Jenis insiden	Pilih salah satu Insiden Keselamatan Pasien (IKP) KTD/KNC/KTC/KPC. Untuk laporan eksternal, KPC tidak perlu dilaporkan.
Orang pertama yg melaporkan Insiden	Pilih salah satu pelapor yang paling pertama melaporkan terjadinya insiden Misal: petugas/ keluarga pasien, dll.
Insiden menyangkut pasien:	Pasien operasi.
Tempat/Lokasi	Tempat pasien berada, misal ruang pemulihan atau kamar operasi
Unit/Departemen yang menyebabkan insiden	Unit/Departemen yang menjadi penyebab terjadinya insiden, contoh: Pasien anak berobat ke poliklinik, diberikan resep, ternyata terjadi kesalahan pemberian obat oleh petugas farmasi. Hal ini diketahui setelah pasien pulang. Ibu pasien datang kembali ke Farmasi untuk menanyakan obat tersebut. Insiden:Salah pemberian obat untuk pasien anak Jenis Insiden: KNC (tidak terjadi cedera) Tempat/Lokasi: Farmasi Spesialisasi: Kasus Anak Unit penyebab : Farmasi
Akibat insiden	Pilih salah satu: (lihat tabel matriks grading risiko)
Tindakan yang dilakukan segera setelah insiden	Ceritakan penanganan/tindakan yang saat itu dilakukan agar insiden yang sama tidak terulang lagi. Tindakan dilakukan oleh Pilihlah salah satu: 1. Bila dilakukan Tim: sebutkan timnya terdiri dari siapa saja misal;dokter,perawat. 2. Bila dilakukan petugas lain: sebutkan misal; analis, asisten apoteker, apoteker



7.6 ANALISIS MATRIKS GRADING RISIKO

Penilaian matriks risiko adalah suatu metode analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan probabilitasnya.

A. Dampak (*consequences*)

Penilaian dampak / akibat suatu insiden adalah seberapa beratakibat yang dialami pasien mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal.

Tabel 7.2 Penilaian dampak klinis / konsekuensi / *severity*

Tingkat Risiko	Deskripsi	Dampak
1	Tidak signifikan	Tidak ada cedera
2	Minor	-Cedera ringan mis. Luka lecet -Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,

3	Moderat	- Cedera sedang mis. Lukarobek - Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/ psikologis atau intelektual (reversibel), tidak berhubungan dengan penyakit. - Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4	Mayor	- Cedera luas/berat missal cacat, lumpuh - Kehilangan fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (irreversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.
5	Katastropik	Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

B. Probabilitas / frekuensi *//likelihood*
 Penilaian tingkat probabilitas / frekuensi risiko adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi.

Tabel 7.3 Penilaian probabilitas/ frekuensi

Tingkat risiko	Probabilitas
1	Sangat jarang / rare (>5 thn/kali)
2	Jarang / unlikely (>2-5 thn/kali)
3	Mungkin / possible (1-2 thn/kali)
4	Sering / likely (bebrp kali /thn)
5	Sangat sering / almost certain (tiap minggu /bulan)

Setelah nilai dampak dan probabilitas diketahui, dimasukkan dalam tabel matriks grading risiko untuk menghitung skor risiko dan mencari warna *bands risiko*.

Skor Risiko :

SKOR RISIKO = Dampak x Probabilitas

- Cara menghitung skor risiko :
 Untuk menentukan skor risiko digunakan matriks grading risiko (tabel 3) :
- Tetapkan frekuensi pada kolom kiri
 - Tetapkan dampak pada baris ke arah kanan,
 - Tetapkan warna bandsnya, berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak.

Tabel 7.4 Matriks grading risiko

Probabilitas	Tidak signifikan 1	Minor 2	Moderat 3	Mayor 4	Katastropik 5
Sangat sering terjadi (tiap minggu /bulan)	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi (beberapa kali/thn)	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi (1-<2 thn/kali)	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim

Jarang terjadi (>2-<5 thn/kali)	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang terjadi (>5 thn/kali)	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim

Keterangan:

- Warna *bands* : hasil pertemuan antara nilai dampak yang diurut kebawah dan nilai probabilitas yang diurut ke samping kanan. Contoh : Pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal kejadian seperti ini di rs x terjadi pada 2 tahun yang lalu
- Nilai dampak : 5 (kata stropik) karena pasien meninggal
- Nilai probabilitas : 3 (mungkin terjadi) karena pernah terjadi 2 tahun
- Lalu *scoring* risiko : 5 x 3 = 15 → warna bands : merah (ekstrim)

C. Bands Risiko

Bands risiko adalah derajat risiko yang digambarkan dalam empat warna yaitu : biru, hijau, kuning dan merah. Warna "bands" akan menentukan investigasi yang akan dilakukan : (tabel 4)

Tabel 7.5 Tindakan sesuai tingkat dan bands risiko

Level / bands	Tindakan
Extreme (sangat tinggi)	Risiko ekstrim, dilakukan rca paling lama 45 hari membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke direktur,
High (tinggi)	Risiko tinggi, dilakukan rca paling lama 45 hari kaji dengan detil & perlu tindakan segera serta membutuhkan perhatian top manajemen,
Moderate (sedang)	Risiko sedang, dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer / pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan kelola risiko
Low (rendah)	Risiko rendah, dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin

Keterangan ;

Bands biru dan hijau: investigasi sederhana oleh Apoteker Penanggung Jawab.

Bands kuning dan merah : investigasi komprehensif / *Root Cause Analysis* (RCA) oleh Tim KP di RS.

BAB VIII KESELAMATAN KERJA

8.1 PENGERTIAN KESELAMATAN KERJA

Ruang Operasi Rumah Sakit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan medik di sarana pelayanan kesehatan. Dalam rangka mendukung Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; maka perlu disusun persyaratan teknis fasilitas ruang operasi rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Kamar operasi adalah suatu unit khusus di rumah sakit, tempat untuk melakukan tindakan pembedahan, baik elektif maupun akut, yang membutuhkan keadaan suci hama (steril). Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan.

8.2 TUJUAN KESELAMATAN KERJA

Mengacu pada pengertian tersebut maka diharapkan setiap petugas rumah sakit dapat menerapkan sistem keselamatan kerja diantaranya:

1. Petugas mengerti SPO penggunaan APD sehingga dapat menggunakan APD sesuai prosedur.
2. Tersedianya APD yang memenuhi standar.
3. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang dibedakan infeksius dan non infeksius serta terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan jarum ataupun spuit bekas.
4. Aturan untuk tidak melakukan recuping jarum suntik setelah dipakai ke pasien.
5. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu
 - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi
 - b. Menggunakan alat pelindung (sarung tangan, kaca mata, sepatu boot / alas kaki tertutup, celemek, masker dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll
 - c. Melakukan tindakan yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, mis: memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
 - d. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik pada 5 momen.
6. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilisasi yaitu:
 - a. Dekontaminasi dengan larutan *alkazime* dan *alkacide*.
 - b. Pencucian dengan dibilas air mengalir
 - c. Pengeringan
7. Menggunakan baju kerja yang bersih

8.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN KARYAWAN

Bila teridentifikasi masalah atau terjadi kecelakaan, maka ada tindakan korektif, dicatat (dokumentasi), dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Penanggung jawab / koordinator K3RS. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat umum.
 - a. Setiap petugas diwajibkan memakai baju khusus kamar operasi
 - b. Tidak di perbolehkan makan/minum dan merokok di dalam ruang kamar operasi
 - c. Tidak boleh menyimpan makanan dan minuman di dalam lemari es bersama formalarium obat

- d. Jaga kebersihan ruang kamar operasi dan bersihkan dengan desinfektan.
 - e. Setiap spesimen harus di perlakukan sebagai bahan infeksius.
2. Kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat khusus yang berkaitan dengan mikroorganisme:
- a. Segera letakkan linen pada jendela infeksius dan segera diambil oleh staf lain untuk dibersihkan
 - b. Melakukan pembersihan 1 minggu sekali diruang kamar operasi
 - c. Menutup kembali jarum dan mengingatkan team akan barang yang tajam.
3. Yang berkaitan dengan bahan kimia:
- a. Beri label pada semua bahan kimia meliputi nama, konsentrasi, tanggal, penerimaan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa, keterangan/peringatan tentang bahaya bahan.
 - b. Bahan kimia disimpan pada ruangan yang terang, tidak sinar matahari langsung dalam lemari/rak secara rapi dan teratur yang bersifat corrosive harus diletakkan di tempat rendah.
4. Yang berkaitan dengan aliran listrik:
- a. Jangan menggunakan cairan atau gas yang mudah terbakar disekitar peralatan listrik.
 - b. Peralatan listrik harus di rawat dan di pelihara
5. Yang berkaitan dengan ruangan kamar operasi.
- Bila ruangan kamar operasi menggunakan AC central, pastikan lampu dalam keadaan siap pakai atau tidak ada kerusakan.

BAB IX PENINGKATAN MUTU

9.1 PRINSIP

Prinsip dasar upaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit.

9.2 DEFINISI INDIKATOR

Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk bisa melihat perubahan. Indikator yang baik adalah yang sensitif tapi juga spesifik.

9.3 KRITERIA

Spesifikasi dari indikator.

9.4 STANDART

Tingkat performance atau keadaan yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang dalam situasi tersebut, atau oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mempertahankan tingkat performance atau kondisi tersebut. Suatu norma atau persetujuan mengenai keadaan atau prestasi yang sangat baik. Sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu. Dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan maka harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aspek yang dipilih untuk ditingkatkan
 - a. Keprofesian
 - b. Efisiensi
 - c. Keamanan dan kepuasan pasien
 - d. Sarana dan lingkungan fisik
2. Indikator yang dipilih
 - a. Indikator lebih diutamakan untuk menilai output daripada input dan proses.
 - b. Bersifat umum, yaitu lebih baik indikator untuk situasi dan kelompok daripada untuk perorangan.
 - c. Dapat digunakan untuk membandingkan antar daerah dan antar Rumah Sakit.
 - d. Dapat mendorong intervensi sejak tahap awal pada aspek yang dipilih untuk di monitor.
 - e. Didasarkan pada data yang ada.
3. Kriteria yang digunakan

Kriteria yang digunakan harus dapat diukur dan dihitung untuk dapat menilai indikator, sehingga dapat sebagai batas yang memisahkan antara mutu baik dan mutu tidak baik.
4. Standar yang digunakan
 - a. Acuan dari berbagai sumber.
 - b. *Benchmarking* dengan Rumah Sakit yang setara.
 - c. Berdasarkan trend yang menuju kebaikan.

BAB X

PENUTUP

Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi mempunyai peranan penting untuk pedoman kerja bagi kamar operasi dalam memberikan pelayanan pembedahan , anastesi untuk memenuhi kebutuhan pasien, sehingga mutu dan keselamatan pasien yang menjalani pembedahan dapat terjamin. Pedoman ini dapat dapat digunakan juga sebagai acuan kerja bagi tenaga perawat di Instalasi Kamar Operasi.

Penyusun Pedoman Instalasi Kamar Operasi ini adalah merupakan langkah awal sebagai suatu proses yang panjang sehingga memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan Instalasi Kamar Operasi dan tujuan Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr.Ifrit Bagus Apriantono, MMRS